

TRIASE DALAM GAWAT DARURAT

RSUD CIPAYUNG



Sejarah Triage

- Konsep awal triase modern → meniru konsep pada jaman Napoleon dimana Baron Dominique Jean Larrey (1766-1842)
- Seorang dokter bedah mengembangkan dan melaksanakan sebuah system perawatan dalam kondisi yang paling mendesak pada tentara yang datang tanpa memperhatikan urutan kedatangan mereka
- Pada tahun 1846, John Wilson memberikan kontribusi bagi filosofi triase. untuk penyelamatan hidup melalui tindakan pembedahan akan efektif bila dilakukan pada pasien yang lebih memerlukan.

Pengertian Triage

Triase berasal dari bahasa Prancis *trier* bahasa Inggris *triage* dan diturunkan dalam bahasa Indonesia *triase* yang berarti sortir.

Triage

- suatu konsep pengkajian yang cepat dan terfokus
- pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan serta fasilitas yang paling efisien
- tujuan untuk memilih atau menggolongkan semua pasien yang memerlukan pertolongan dan menetapkan prioritas penanganannya (Kathleen dkk, 2008).

Pengertian Triage

Triage adalah usaha pemilahan korban sebelum ditangani, berdasarkan tingkat kegawatdaruratan trauma atau penyakit dengan mempertimbangkan prioritas penanganan dan sumber daya yang ada.

Tujuan Triage

1. Mengidentifikasi kondisi mengancam nyawa.
2. Menetapkan tingkat atau derajat kegawatan yang memerlukan pertolongan kedaruratan.

Dengan triage tenaga kesehatan akan mampu :

1. Menginisiasi atau melakukan intervensi yang cepat dan tepat kepada pasien
2. Menetapkan area yang paling tepat untuk dapat melaksanakan pengobatan lanjutan
3. Memfasilitasi alur pasien melalui unit gawat darurat dalam proses penanggulangan/pengobatan gawat darurat

Sistem Triage dipengaruhi

- Jumlah tenaga profesional dan pola ketenagaan
- Jumlah kunjungan pasien dan pola kunjungan pasien
- Denah bangunan fisik unit gawat darurat
- Terdapatnya klinik rawat jalan dan pelayanan medis

Keadaan yang akan mempengaruhi proses triage :

➤ **Multiple Casualties:**

Keadaan ini terjadi bila musibah masal dengan jumlah penderita dan beratnya perlukaan tidak melampaui kemampuan petugas dan peralatan . Dalam keadaan ini penderita dengan masalah yang mengancam jiwa dan multipel trauma akan dilayani terlebih dahulu

➤ **Mass Casualties**

Keadaan ini terjadi bila musibah masal dengan jumlah penderita dan beratnya perlukaan melampaui kemampuan petugas dan peralatan . Dalam keadaan ini yang akan dilayani terlebih dahulu adalah penderita dengan kemungkinan hidup terbesar , butuh waktu /perlengkapan/tenaga paling sedikit .

Prinsip-prinsip triage :

“Time Saving is Life Saving, The Right Patient, to The Right Place at The Right Time serta melakukan yang terbaik untuk jumlah terbanyak”.

Seleksi korban berdasarkan :

- Ancaman jiwa mematikan dalam hitungan menit
- Dapat mati dalam hitungan jam
- Trauma ringan
- Sudah meninggal

Trauma Life Support

A

Snoring → OPA, gurgling → Suction

Proteksi airway dan stabilisasi cervical

- Chin lift atau Jaw Thrust
- Intubasi, Krikotiroitomi
- Cervical Control → Neck Collar

B

Oksigenasi, cek RR, otot bantu napas

- Ventilasi → Nasal Kanul, Simpel Mask, NRM
 - Tension pneumothoraks → Needle Thoracosintesis
 - Open Pneumothorax → tempel kassa kedap udara dengan di plester di 3 sisi
- Terapi utama WSD

C

Cek nadi → HR, Akral, dan CRT

Resusitasi cairan dan control perdarahan → Pasang infus 2 line

Resusitasi cairan : RL – NaCl, tidak boleh Dx

- Balut tekan perdarahan

D & E

DISABILITY & NEUROLOGICAL STATUS

Nilai Kesadaran

- AVPU
 - Alert
 - Voice
 - Pain
 - Unresponsive
- *Glasgow Coma Scale (GCS)*

Nilai adanya defisit neurologis

- Pupil anisokor
- Gerak bola mata terhambat
- Kelemahan 1 sisi
- Mulut mencong
- Bicara pelo

EXPOSURE

Ekspos seluruh tubuh pasien

- Jika ada luka terbuka dengan perdarahan aktif -> balut tekan, kassa, kassa gulung, elastis verban
- Torniket ---> Jangan dilakukan : merusak jaringan sehat

Lindungi pasien dari keadaan hipotermia

Lalu lakukan Log Roll untuk memeriksa bagian posterior dari pasien(bisa dilakukan belakangan)

Jenis Pemeriksaan	Nilai
Respon buka mata (Eye opening/E) 1. Spontan 2. Terhadap suara 3. Terhadap nyeri 4. Tidak ada respon	4 3 2 1
Respon motorik terbaik (M) 1. Ikut perintah 2. Melokalisir nyeri 3. Fleksi normal (Menarik anggota yang dirangsang) 4. Fleksi abnormal (Dekortikasi) 5. Ekstensi abnormal (Deserebsasi) 6. Tidak ada respon (Flasib)	6 5 4 3 2 1
Respon verbal 1. Berorientasi baik 2. Berbicara mengacau (Bingung) 3. Kata-kata tidak teratur 4. Suara tidak jelas 5. Tidak ada respon	5 4 3 2 1

Pemilahan Pasien secara Perorangan (Single Patient Triage)

A. Emergent

Pasien-pasien dengan kategori ini merupakan prioritas pertama. Mereka harus dilihat dan ditangani agar memperoleh penanganan yang tepat dan segera.

Contohnya:

- Trauma Mayor
- Acute Myocardial Infarction
- Sumbatan Jalan Napas
- Syok
- Anafilaksis

1. Pemilahan Pasien secara Perorangan (Single Patient Triage)

B. Urgent

- Sudah harus ditangani dalam hitungan jam.
- pasien-pasien yang secara fisiologi stabil pada saat mereka datang, tetapi dalam resiko pemburukan jika tidak ditangani dalam beberapa jam.

Contoh:

- Spinal Injury
- Stroke (Cerebro Vascular Accident)
- Appendicitis Acuta
- Cholecystitis

C. Non Urgent

- * Pasien-pasien cedera yang dapat berjalan kaki/ memiliki kondisi sakit yang ringan termasuk dalam kategori ini.
- * Termasuk juga pasien-pasien yang stabil secara hemodinamik tetapi tampak cedera.

Contoh:

- Laserasi kulit
- Luka abrasi dan luka lainnya
- Fraktur tertentu dan dislokasi
- Demam dan kondisi medis lainnya yang termasuk kategori ini

ATS (Australian Triage Scale)

ATS Category	ATS waiting times	Performance indicator threshold
1 (Resuscitation)	Immediate	100%
2 (Emergent)	10 minutes	80%
3 (Urgent)	30 minutes	75%
4 (Semi-urgent)	60 minutes	70%
5 (Non-urgent)	120 minutes	70%

ATS

1. Resusitasi → Immediately

- Cardiac/respiratory arrest, obstructive airway, syok (BP<80 mmHg), penurunan kesadaran → **AVPU**, gangguan psikiatri berat → suicide

2. Emergent → 10 menit

- HR obstructive airway → snoring/gurgling, respiratory distress berat, sirkulasi compromise → diare dehidrasi berat, **KET, AAA, PE, & AVPU**

3. Urgent → 30 menit

- Severe hypertension, on going bleeding → blm syok, kejang

4. Semi Urgent → 60 menit

- Perdarahan ringan, benda asing pada jalan napas tnp obstruksi, nyeri sedang

5. Non-Urgent → 120 menit

- Minimal pain, gejala2 simptomatik

Kode Warna International Dalam Triage





Prioritas 1 atau Emergensi

Warna **MERAH** (kasus berat) Pasien dengan kondisi mengancam nyawa, memerlukan evaluasi dan intervensi segera, perdarahan berat, pasien dibawa ke ruang resusitasi,

waktu tunggu 0-10 MENIT, seperti :

- Asfiksia, cedera cervical, cedera pada maxilla
- Trauma kepala dengan koma dan proses shock yang cepat
- Fraktur terbuka dengan gangguan neurovaskular
- Luka bakar > 30 % / Extensive Burn dengan cedera inhalasi
- Shock tipe apapun



Prioritas 2 atau Urgent

warna **KUNING** (kasus sedang)

Pasien dengan penyakit yang akut, mungkin membutuhkan trolley, kursi roda atau jalan kaki,

waktu tunggu 30-60 menit, area critical care, seperti :

- Trauma thorax non asfiksia
- Fraktur terbuka tanpa gangguan neurovaskular
- Fraktur tertutup pada tulang panjang
- Luka bakar terbatas (< 30% dari TBW)
- Cedera pada bagian / jaringan lunak



Prioritas 3 atau Non Urgent

warna **HIJAU** (kasus ringan)

Pasien yang biasanya dapat berjalan dengan masalah medis yang minimal, luka lama,

Waktu tunggu **60-120 MENIT.**

kondisi yang timbul sudah lama, area ambulatory / ruang P3, seperti :

- Minor injuries
- Seluruh kasus-kasus ambulatory / rawat jalan



Priority 0

Prioritas 0

warna HITAM (kasus meninggal)

- Tidak ada respon pada semua rangsangan
- Tidak ada respirasi spontan
- Tidak ada bukti aktivitas jantung
- Tidak ada respon pupil terhadap cahaya

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG**

Jl. Mini III RT 04 RW 003, Kelurahan Bambu Apus,
Kecamatan Cipayung - Jakarta Timur

Nomor RM :
Nama :
Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : L / P
(Mohon diisi atau tempelkan stiker jika ada)

LEMBAR TRIASE GAWAT DARURAT**RIWAYAT DATANG**

Petunjuk : Berikan tanda (√) pada kolom yang anda anggap sesuai dengan kondisi pasien

Tanggal masuk / Jam : / WIB

Cara masuk IGD:

- ☐ Jalan kaki ☐ Brankar ☐ Lain - lain
☐ Kendaraan/ambulans ☐ Kursi roda

Asal masuk :

- ☐ Datang sendiri ☐ Poliklinik ☐ Diantar polisi
☐ Rujukan, dari. ☐ lain – lain.

Jenis kasus :

- ☐ Trauma ☐ Non Trauma ☐ Obgyn

Dead On Arrival

- ☐ Tidak ada tanda-tanda kehidupan
☐ Tidak ada denyut nadi
☐ RC -/-
☐ EKG Flat

Jam DOA :

TRIASE

Keluhan Utama :

Tanda Vital	Tekanan Darah : mmHg	Suhu : °C	Sat. O2 : %
	Nadi : x/menit	Nafas : x/menit	Alergi :

PEMERIKSAAN	Gawat Darurat (MERAH)	Gawat Tidak Darurat (KUNING)	Tidak Gawat Tidak Darurat (HIJAU)
-------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

KESADARAN	☐ GCS < 9 (E _ , V _ , M _)	☐ GCS 9 – 14 (E _ , V _ , M _)	☐ GCS 15 (E _ , V _ , M _)
-----------	--	---	---

AIRWAY	☐ Sumbatan jalan nafas parsial/total	☐ Bebas	☐ Bebas
--------	---	--------------------------------	--------------------------------

BREATHING	☐ Henti nafas/Distres nafas berat	☐ Distres nafas ringan	☐ Frek. Nafas normal
-----------	--	---	---

CIRCULATION	☐ Gangguan haemodinamik berat/ Perdarahan tidak terkontrol	☐ Gangguan haemodinamik ringan	☐ Stabil
-------------	--	---	---------------------------------

NYERI	☐ Berat	☐ Sedang - Berat	☐ Tidak nyeri - Ringan
-------	--------------------------------	---	---

STATUS MENTAL	☐ Tidak mampu mengikuti perintah sama sekali	☐ Mampu – tidak mampu mengikuti perintah sama sekali	☐ Mampu mengikuti perintah
---------------	--	--	---

Kategori ATS (Australian Trauma Scale)

☐ Merah	☐ Resusitasi	☐ Emergency	0 – 10 menit
☐ Kuning	☐ Urgent/Darurat	☐ Semi Darurat	10 – 30 menit
☐ Hijau	☐ Tidak Darurat		60 – 120 menit

Verifikator

Jakarta, Jam

Petugas Triase

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

Kunci Penting

1. Area penilaian / triase : mudah diakses dan jelas tandanya.
 - Pemeriksaan pasien
 - Sarana komunikasi antara pintu masuk dan area penilaian
 - Privasi
2. Perlindungan staff IGD
3. Korban trauma harus dialokasikan kategori triase sesuai dengan kegawatan klinis yang terlihat.
4. Pasien dengan kesehatan mental atau masalah perilaku prioritaskan

Siapa yang melakukan
proses triase pertama ?

oleh petugas pertama ditempat

Tujuan Penerapan Triase dan Standar Sistem Triase ?

- sesuai dengan kriteria klinis
- mengoptimalkan keselamatan dan efisiensi pelayanan darurat berbasis-rumah sakit

Sistem Triase → bila efektif ?

- a. Sebagai jalan tempat masuk tunggal untuk semua pasien datang
- b. Lingkungan fisik yang sesuai untuk melakukan pemeriksaan singkat. Juga diperlukan
- c. Sebuah sistem penerimaan pasien yang terorganisir
- d. Didapatnya data yang tepat waktu untuk kebutuhan pemberian pelayanan





Thank you